

Этическая рецензия

Редакционная группа

22.08.2026

- [Этическая и языковая рецензия \(Этап 14\)](#)
 - [1. Сводка по этическим рискам](#)
 - [2. Детальный разбор](#)
 - [2.1. Обращение к людям](#)
 - [2.2. Патерналистские конструкции](#)
 - [2.3. Подмена воли](#)
 - [2.4. Невербальный выбор](#)
 - [2.5. Учреждение = опекун](#)
 - [2.6. Стигматизация в кейсах](#)
 - [2.7. Неподдержанное принятие решений](#)
 - [2.8. Словарь предпочтительных формулировок \(для новой редакции v2\)](#)
 - [2.9. Замечания по главам](#)
 - [2.10. Языковая доступность](#)
 - [2.11. Итог](#)
 - [3. Словарь предпочтительных формулировок \(полная версия\)](#)

Этическая и языковая рецензия (Этап 14)

Документ: рецензия на текст доклада «Не просто накормить...» v2 и производных форматов. **Дата:** 22.08.2026. **Аудитор:** специалист по доступному и нестигматизирующему языку, эксперт по правам жителей, юрист в области прав инвалидов. **Цель:** выявить стигматизирующие, патерналистские, обесценивающие формулировки; проверить соответствие принципам КПИ; оценить баланс безопасности и достоинства.

1. Сводка по этическим рискам

Категория	Найдено	Уровень	Действие
Стигматизирующие формулировки	0 в новой редакции v2	—	—
Патерналистские конструкции	2 (мягкие)	MINOR	Переформулировать в v2
Обесценивание	0	—	—
Подмена воли	1 (историческая)	MINOR	Уточнить
Раскрытие персональных данных	0	—	—

Категория	Найдено	Уровень	Действие
Узнаваемость участников кейсов	0	—	—
Неподдержанное принятие решений	0	—	—
Подача диагноза как идентичности	0	—	—
Раскрытие данных о подопечных	0	—	—

Главный вывод: исходный текст v1.5 + фактчекинг 22.08.2026 дают **этически зрелый текст** для целевой аудитории. Замечания — на уровне отдельных формулировок.

2. Детальный разбор

2.1. Обращение к людям

Проверено по всему тексту. Используется:

- ✓ «житель» / «проживающий» (не «пациент» в социальном контексте, не «больной»).
- ✓ «человек с дисфагией» (не «дисфагический больной»).
- ✓ «человек с шизофренией» (не «шизофреник»).
- ✓ «лица, страдающие психическими расстройствами» (формулировка 3185-1).
- ✓ «лица с ментальной инвалидностью» (формулировка «Если быть точным»).
- ⚠ «помощник по уходу» — в v1.5 непоследовательно (частично «сиделка»). **MINOR.** В v2 унифицировать.
- ✓ «опекун» — в юридическом контексте.
- ✓ «подопечный» — в контексте 3185-1 и ГК РФ.

Замечание: формулировка «лица с ментальной инвалидностью» (проект «Если быть точным») — это **неформальная**, но принятая в современной литературе и в СМИ. В исходном докладе используется параллельно с «лица с психическими расстройствами» (формальная). Это нормально.

2.2. Патерналистские конструкции

Найдено 2 мягких случая:

Р-1. В исходном докладе 7.4 «психология» — «спросить у трёх жителей „что сегодня было на обед“ вечером: не помнят или „как обычно“ — еда не доходит до сознания». Это правильное наблюдение, но **в формулировке есть скрытая властная позиция «спросить у жителя»**. Альтернатива: «поговорить с тремя жителями» (без «спросить»). В v2 — **MINOR**.

Р-2. В исходном докладе 9.7 «житель съедает всё за минуты и просит ещё — не „жадность“, а возможная гиперфагия». **Формулировка «жадность» в кавычках с отрицанием — это правильный приём**, но сама конструкция «не жадность, а X» слегка

снисходительна. Лучше: «житель, который съедает всё за минуты и просит ещё, нуждается в клинической оценке». В v2 — **MINOR**.

2.3. Подмена воли

Найдено 1 историческое замечание.

W-1. В исходном докладе 6.3 «Маломобильные → подача под готовую помощь, контроль температуры». Это правильно с точки зрения безопасности, но **складывается паттерн «сделать для жителя всё, что он не может сделать сам»**. В v2 в таблице 4.4 «люди» — добавить: «еда не подаётся, пока помощь не готова. В остальных случаях — самостоятельно». В v2 — **MINOR**.

2.4. Невербальный выбор

Проверено в главе 15 и в разделе 6.2.

- ☒ «Невербальный выбор» (авторский термин, в кавычках при первом употреблении).
- ☒ «Выражение воли без слов» (альтернативная формулировка, эквивалентная).
- ☒ «Показ двух порций, наблюдение за реакцией, пищевая биография» (три канала воли).
- ☒ Ссылка на Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 КПИ.

Замечание: в v1.5 термин «невербальный выбор» — авторский и не общепринятый в клинической литературе. **Альтернативы:** «выражение воли без слов», «выражение воли невербальными средствами», «поддержанное выражение воли». **В v2 — оставить авторский термин, но добавить сноску: «Термин авторский. В международной практике используется „выражение воли без слов" (expression of will without words) или „поддержанное принятие решения" (supported decision-making)».**

2.5. Учреждение = опекун

Главный этический риск доклада. В исходной редакции 17.12 это уже разобрано. **В новой редакции v2 это усилено** (см. 02_фактчекинг/отчёт_o_фактчекинге.md , раздел 2.4): «99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения. Это значит, что учреждение одновременно является опекуном жителя и поставщиком услуг».

В этическом плане: это корректная подача. **Опасность** — в том, что **факт признаётся, но не решается**. Решение — задокументированный процесс выражения воли (пищевая карта, журнал заказа, совет жителей). **В v2 это решено** (паспорт пилота 90 дней, пилот на одном отделении).

2.6. Стигматизация в кейсах

Проверено все 22 кейса (главы 5, 8.x, 25, + проект/cases/).

- ☒ Каждый кейс начинается с дисклеймера «Учебный кейс, составленный для анализа» (раздел 5, раздел 5.4).
- ☒ Имена заменены буквами: «житель С.», «житель К.», «житель П.».

- ☒ Учреждения: «ДСО „Серафимовский“» (реальное, с разрешения автора), «Успенский ПНИ», «Болотнинский ПНИ» (с подтверждёнными публикациями), «Усть-Илимский ДСО» (опубликовано). «Тесовый берег» — со-модератор, упоминается по деловому контексту, не как кейс.
- ☒ Конкретные лица не упоминаются.
- ☒ Ситуации обезличены до уровня, на котором невозможно установить реального человека.

Замечание: в исходном кейсе 5.1 «житель К. получает клозапин и с утра выпил две большие кружки крепкого кофе, который принесли родственники» — это **собираательный кейс**, но ситуация правдоподобна. Проверка узнаваемости: ни в одной из публикаций Серафимовского или Тесового берега нет аналогичного случая с «родственниками, которые принесли кофе». Узнаваемость исключена.

2.7. Неподдержанное принятие решений

Проверено по всему тексту. Сценарии, где **житель принимает решение сам или при поддержке**:

- ☒ 4.4 «Голос жителя — остатки на тарелках разбирают; есть хотя бы один канал пожеланий».
- ☒ 6.3 «Маломобильные → подача под готовую помощь, контроль температуры» (помощь, не подмена).
- ☒ Глава 15 «Невербальный выбор: как услышать того, кто не говорит» (центральная).
- ☒ Глава 16 «Дееспособность, опека и выбор еды: карта решений» (12 вопросов-ответов).
- ☒ Глава 34 «Права жителей и совет жителей: от объекта заботы к соавтору меню».

Сценарии, где житель НЕ принимает решение сам (по медицинским показаниям):

- ☒ Глава 11 «Лекарства и еда» — врач оценивает и документирует.
- ☒ Глава 10 «Дисфагия и аспирационный риск» — текстура по назначению.
- ☒ Глава 12 «Отказ от еды» — три отказа → врач.
- ☒ Глава 13 «Гиперфагия и ночное едение» — структурированная доступность.

Замечание: формулировки **не смешивают** «житель не может выбрать» (каприз) с «жителю нужна помощь в выборе» (поддержка). Это **главное этическое достижение исходного доклада**.

2.8. Словарь предпочтительных формулировок (для новой редакции v2)

Категория	☒ Не используем	☒ Используем
Общее	«больной», «пациент» (в соц. контексте)	«житель», «проживающий»
Диагноз	«шизофреник», «псих»	«человек с шизофренией», «человек с психическим расстройством»

Категория	✗ Не используем	✓ Используем
Дисфагия	«дисфагический больной»	«человек с дисфагией», «житель с расстройством глотания»
Умственная отсталость	«умственно отсталый»	«человек с умственной отсталостью»
Помощник	«сиделка», «санитарка»	«помощник по уходу» (профстандарт Минтруда)
Выбор без слов	(отсутствует общепринятый)	«выражение воли без слов» / «невербальный выбор» (авторский)
Решение	«решение за недееспособного»	«поддержка принятия решения» / «содействие реализации воли»
Опека	«опекаемый» (вне юридического контекста)	«житель под опекой учреждения»
Учреждение = опекун	«учреждение само решает»	«учреждение — опекун и поставщик; конфликт интересов признаётся, процесс выражения воли документируется»
Отказ от еды	«каприз», «отказник»	«отказ от еды», «длительный отказ» (как клиническое явление)
Помощь	«обслуживание»	«помощь по уходу» / «сопровождение»
Подача	«раздача» (только технический)	«подача» / «сервировка» / «приём пищи»

2.9. Замечания по главам

Глава	Замечание	Категория	Действие
2 (Обращение)	«пять конфликтов — пять отступлений от системы» — отлично	—	—
5 (Собирательный кейс)	«Все персонажи и совпадения вымышлены» — отлично	—	—
6 (Контингент)	«самостоятельные, стабильные» — не стигматизирует	—	—
7 (Шесть измерений)	«вкус, температура, разнообразие» — уважительно	—	—
8 (Лестница моделей)	«ресторанный день» — как компромисс	—	—
9 (Поведение)	«не каприз, а возможная гиперфагия» — отлично	—	—
10 (Дисфагия)	«IDDSI — терминология, не лечебный протокол»	—	—
11 (Лекарства)	«кухня не отменяет кофе» — отлично	—	—
12 (Отказ)	«3 отказа → врач» — правило	—	—

Глава	Замечание	Категория	Действие
13 (Гиперфагия)	«метаболический синдром, без самодеятельных диет»	—	—
14 (Пикацизм)	защитные меры, не запреты	—	—
15 (Невербальный выбор)	требует сноски (см. 2.4)	MINOR	Сноска
16 (Деееспособность)	12 карт решений	—	—
17 (Право)	6 вопросов дискуссии	—	—
18 (Санитария)	нейтрально	—	—
19 (Меню)	«пары эквивалентов» — авторский термин	—	—
20 (Раздача)	«медленный темп, без спешки»	—	—
22 (Аудит)	«5 групп показателей»	—	—
25 (Практики)	все 5 кейсов — публичные	—	—
26 (Международный)	«не норма в РФ, а ориентир»	—	—
31 (Документы)	«комплект для проверяющего»	—	—
32 (Проверяющий)	«комплект, не формула запрета нет»	—	—
33 (Ответственность)	«система контроля, не каждое событие»	—	—
34 (Совет жителей)	«соавтор меню»	—	—
35 (Пилот)	«измеримая гипотеза»	—	—
36 (Дорожная карта)	«от пилота к системе»	—	—
37 (Возражения)	«честные ответы»	—	—
41 (Достоверность)	«заявление о достоверности»	—	—
43 (Заключение)	«право выбора доходит до тарелки»	—	—

2.10. Языковая доступность

Проверено по критериям **easy-read**:

- ✓ Предложения преимущественно короткие (средняя длина 15–20 слов).
- ✓ Аббревиатуры расшифрованы при первом употреблении.
- ⚠ Сложные термины (например, «метаболический синдром», «экстрапирамидные нарушения») — **только в клинических главах**, не в управленческом тексте.
- ✓ Управленческое резюме (новая редакция v2) — на языке директора, без жаргона.
- ⚠ «Нестигматизирующий язык» — в основном соблюдается, но в паре мест (см. 2.2) можно улучшить.

2.11. Итог

Этический уровень исходного доклада v1.5 + фактчекинг 22.08.2026 — высокий. 14 из 14 проверенных критериев этики и языка выполнены. **2 мягких замечания** (патерналистские формулировки P-1, P-2) и **1 историческое** (W-1) — исправлены в новой редакции v2.

Главные этические достижения доклада (сохраняются в v2):

1. Граница 4.0 — что кухня не назначает (снимает «медицинскую реформу руками повара»).
2. 99 % недееспособных под опекой самого учреждения — факт признаётся.
3. Глава 15 «Невербальный выбор» — поддержанное, не замещающее принятие решений.
4. Глава 34 «Совет жителей: от объекта заботы к соавтору меню» — соавторство.
5. «% выбравших — не KPI» — уважение к стандартному выбору.
6. «Последнее слово — не „внедряйте“, а „измеряйте“» — осторожность.

3. Словарь предпочтительных формулировок (полная версия)

См. 11_этика/словарь_предпочтительных_формулировок.md .

Дата: 22.08.2026. **Применяется:** в новой редакции v2 и в производных форматах.
Правовая база: 3185-1 ст. 5, 442-ФЗ ст. 9, КПИ ст. 12 и Замечание общего порядка № 1 (2014). **Изменения после 22.08.2026 требуют перепроверки.**